

Personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires

Envejecimiento, desigualdad
y políticas públicas

Una agenda urbana para una Ciudad que envejece

PUBLICACIÓN

Septiembre
2026

FUENTES PRIMARIAS

IDECBA / ANSES
Defensorías / GCBA

ENFOQUE TEMÁTICO

Demografía
y cuidados

ALCANCE TERRITORIAL

Ciudad de
Buenos Aires

Personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires

Envejecimiento, desigualdad y políticas públicas

Autoría institucional: CEPOES · Centro de Estudios en Política, Economía y Sociedad
· Somos 100 Barrios.

17,2%	de la población tiene 65 años o más
60,7%	de la población mayor son mujeres
20,3%	personas de 65+ en la Comuna 2
11,1%	personas de 65+ en la Comuna 8

Síntesis ejecutiva

Buenos Aires es la jurisdicción más envejecida del país. Pero la vejez porteña no constituye una experiencia homogénea: los ingresos, el género, la vivienda, el barrio, la red familiar y el acceso a cuidados producen trayectorias muy diferentes. El envejecimiento exige pasar de respuestas fragmentadas a una política urbana integral de autonomía, cuidados y derechos.

Contenido

- I. Demografía y territorio
 - II. Ingresos y costo de vida
 - III. Hábitat y redes de cuidado
 - IV. Salud y cobertura
 - V. Cuidados de larga duración
 - VI. Nudos críticos
 - VII. Recomendaciones estratégicas
- Fuentes y metodología

I. Demografía y territorio

La Encuesta Anual de Hogares 2025 ubica en 17,2% la proporción de residentes de 65 años y más. El envejecimiento combina una fecundidad muy baja, mayor longevidad y el crecimiento del grupo de edad avanzada. La feminización es central: seis de cada diez personas mayores son mujeres y la brecha de esperanza de vida condiciona ingresos, cuidados y soledad en la vejez.

La distribución territorial es desigual. Con base en el Censo 2022, la Comuna 2 registra 20,3% de población de 65 años y más y la Comuna 13, 20,2%. En el sur, la Comuna 8 registra 11,1% y la Comuna 4, 13,7%. Una proporción menor de personas mayores no implica menor necesidad: también puede expresar desigualdades acumuladas en las condiciones de vida y la longevidad.

Tres configuraciones urbanas

El norte presenta una estructura más envejecida, hogares pequeños y mayor supervivencia en edades avanzadas. El centro muestra un perfil maduro y relativamente estable. El sur combina una población más joven con mayores privaciones socioeconómicas y ambientales. La política pública debe leer estas diferencias sin convertirlas en estereotipos territoriales.

II. Ingresos y costo de vida

La jubilación mínima con bono alcanzó \$489.775,92 en agosto de 2026 y \$498.633,20 en septiembre. El bono extraordinario permanece congelado en \$70.000 desde marzo de 2024; por eso, aunque el haber base se actualiza mensualmente, el ingreso consolidado pierde poder adquisitivo.

Las canastas disponibles miden hogares distintos y no deben compararse sin aclaración. La Defensoría de la Tercera Edad estimó en marzo de 2026 una canasta individual de \$1.824.682. La Defensoría del Pueblo porteña calculó para junio de 2026 una canasta de pareja de \$1.639.508 con vivienda propia y de \$2.422.868 si paga alquiler. La vivienda define por sí sola una diferencia decisiva.

Referencia	Monto mensual	Cobertura del ingreso mínimo
Canasta individual del jubilado	\$1.824.682	26,8% con un haber mínimo y bono de agosto
Pareja mayor, vivienda propia	\$1.639.508	59,7% con dos haberes mínimos de agosto
Pareja mayor que alquila	\$2.422.868	40,4% con dos haberes mínimos de agosto

III. Hábitat, soledad y redes de cuidado

La gran mayoría de las personas mayores vive en hogares particulares. En una ciudad donde 73,7% de las viviendas son departamentos, la accesibilidad de edificios, ascensores, veredas y transporte incide directamente sobre la autonomía. Las expensas y el alquiler agregan presión sobre ingresos fijos.

Vivir solo es una condición extendida y fuertemente feminizada: 45,9% de las mujeres de 65 años y más vive sola, frente a 26,3% de los varones. La soledad residencial no equivale necesariamente a aislamiento, pero aumenta el riesgo cuando faltan redes comunitarias, servicios de proximidad y apoyos domiciliarios.

IV. Salud y cobertura

La cobertura formal de salud es alta entre las personas mayores, pero el sistema está fragmentado entre hospitales públicos, obras sociales —con PAMI como principal asegurador— y medicina prepaga. Las diferencias aparecen en los tiempos de espera, los prestadores disponibles, la continuidad de tratamientos y el gasto de bolsillo en medicamentos.

El acceso efectivo no depende sólo de contar con cobertura. También requiere turnos oportunos, proximidad territorial, información comprensible, medicamentos disponibles y coordinación entre niveles de atención. Cuando las cuotas privadas o los copagos resultan inaccesibles, la demanda migra hacia hospitales y centros de salud públicos ya exigidos.

Dimensión	Hospitales GCBA	PAMI / obras sociales	Medicina prepaga
Acceso	Gratuito en el punto de atención	Descuento sobre el haber	Cuota privada
Riesgo principal	Demoras y saturación	Cartillas, turnos y medicamentos	Costo y permanencia
Prioridad	Fortalecer cercanía y derivación	Continuidad y cobertura efectiva	Regulación y transparencia

V. Cuidados de larga duración

La oferta de residencias y apoyos domiciliarios es insuficiente para una población que envejece. La escasez de plazas públicas y el costo de la oferta privada trasladan el cuidado hacia los hogares, en especial hacia las mujeres. El problema no se resuelve únicamente con instituciones: requiere un continuo de apoyos que priorice la autonomía y la permanencia en la comunidad.

La expansión del sector privado convive con establecimientos de muy distinta calidad. La fiscalización, la información pública sobre habilitación y sanciones, y los mecanismos de denuncia son componentes de una política de derechos, no sólo controles administrativos.

VI. Nudos críticos

Brecha previsional: los ingresos mínimos quedan muy por debajo de las canastas de referencia, especialmente cuando existe gasto de alquiler o medicamentos.

Desigualdad territorial: el norte concentra mayor proporción de personas mayores, mientras el sur acumula desventajas que pueden reducir la longevidad y agravar la dependencia.

Fragmentación institucional: Nación, Ciudad, obras sociales, prestadores privados y familias intervienen sin un sistema integrado de cuidados.

Infraestructura limitada: faltan apoyos domiciliarios, plazas accesibles, servicios de respiro y dispositivos de salud mental y deterioro cognitivo de proximidad.

VII. Recomendaciones estratégicas

1. Presupuesto con enfoque territorial. Publicar metas físicas e inversión por comuna y priorizar infraestructura sociosanitaria en territorios con mayor déficit de servicios.

2. Sistema local de cuidados. Crear un registro y un esquema de apoyos domiciliarios, profesionalizar el trabajo de cuidados y ampliar servicios de respiro para familias.
3. Red de salud mental y deterioro cognitivo. Fortalecer CeSAC y hospitales con equipos gerontológicos, talleres de memoria, detección temprana y apoyo a personas cuidadoras.
4. Ciudad accesible. Integrar vivienda, veredas, transporte, cercanía comercial y equipamientos en una agenda de autonomía para envejecer en el propio barrio.
5. Información pública continua. Consolidar datos comparables sobre ingresos, cuidados, residencias, listas de espera, cobertura y resultados, con desagregación territorial y de género.

. Fuentes y metodología

El informe integra estadísticas oficiales, documentos de organismos públicos y fuentes institucionales. Los porcentajes por comuna de población de 65 años y más corresponden al Censo 2022; las estimaciones de la estructura poblacional de la Ciudad, a la EAH 2025. Las canastas citadas refieren a hogares diferentes y se presentan con esa advertencia. Los montos son nominales y corresponden al mes indicado.

Fuentes principales: IDECBA, Encuesta Anual de Hogares 2025 e Informe de Resultados N.º 2041; IDECBA, Censo 2022, Informe N.º 1877; ANSES, haberes previsionales 2026; Defensoría del Pueblo de CABA, canasta de consumo de personas mayores e IPM; Defensoría de la Tercera Edad, canasta básica de mayores; GCBA, hogares de residencia permanente; PAMI, cobertura de medicamentos; UBA y organizaciones especializadas en deterioro cognitivo y demencias.